

上准确运用有很大指导意义。但若按微量元素含量多少来将中药进行全面分类,并指导临床用药是不妥当的。因为中药的治疗作用,其所含的微量元素的作用只能是其中的一方面,如人参、灵芝等,重要的问题在于应致力于探讨这些微量元素的作用与中药

其它成份作用间的相互关系。避免上述偏差,将使中药研究少走弯路,多出成果,为发掘、继承和发展祖国中药学作出更大贡献。

收稿日期 1995—09—11

硝苯吡啶的药物相互作用

李 青 赵晶磊

(卫生科)(郓城县医院)

关键词 硝苯吡啶;药理学;相互作用

1 **心得安** 二药合用可发挥硝苯吡啶扩张冠状动脉和周围血管,降低心脏后负荷,增加心肌供血,氧耗减少的作用,同时由于血压下降,反射性引起心率加快,心得安可以对抗这一副作用。两药具有不同的抗心绞痛机制,合用于高血压,降压效果增强并延长,并可减轻硝苯吡啶引起的潮红,疲乏等不良反应。

2 **地高辛** 地高辛具有中度正性肌力作用,硝苯吡啶主要扩张周围血管包括冠状血管,减轻心脏后负荷,增加冠脉供血,对心肌抑制作用不明显,在治疗量时,对窦房结和房室结功能影响小。二药合用于充血性心力衰竭时疗效增强。

3 **硝酸酯类** 硝苯吡啶属于钙拮抗剂,能使周身血管包括冠状动脉的血管张力减低而扩张,因而降低血压,增加冠状动脉侧枝循环,增加冠脉供血,还能抑制心肌收缩,氧耗减少,延长心肌细胞生存,防止心肌再灌注损伤,缓解心绞痛。硝酸酯类以扩张静脉为主,减低心脏前负荷,兼有较轻的动脉扩张作用(硝酸甘油扩张冠脉间交通枝作用最明显)。两种药

物合用可发挥协同作用,解除冠脉痉挛,用于积压型心绞痛的治疗。

4 **胺碘酮** 胺碘酮能抑制交感神经的活动,减低窦房结自律性和延长房室结不应期,二药合用更减慢窦性心率,增加房室传导阻滞,可引起心脏停搏。

5 **硫甲丙脯酸** 二者都是通过减少周围血管阻力降低血压,虽然血管扩张机制不同,但血压下降最长时间和血压回升坡度相类似,二药合用时,降压效果增加,血压持续降低。硫甲丙脯酸还能减轻硝苯吡啶的心率增快反应和踝部浮肿,对重症高血压,二药合用比单一用药为佳。

6 **氨茶碱** 硝苯吡啶可抑制心肌的收缩性,并引起周围血管扩张,氨茶碱具有正性心肌收缩效应,但和硝苯吡啶一样可使血管平滑肌松弛,故氨茶碱可逆转硝苯吡啶的血液动力学效应,用于慢性阻塞性肺部疾患及顽固性心衰的治疗。

7 **消炎痛** 硝苯吡啶抑制前列腺素E的合成,故二者合用致肾功能恶化。

收稿日期 1995—09—11

女性激素的临床应用进展

何常英 张锐利

(菏泽市精神病医院) (卫生科)

关键词 雌激素;治疗学;发展趋势

女性激素主要以注射和口服形式用于妇产科,随着科学的发展,其剂型不断改进,用途不断扩大到其它医学科,新药也层出不穷,现将近年来的进展综述如下:

促宫颈成熟剂普拉睾酮,曾用名去氢表雄酮,为人肾上腺分泌的内源性甾体激素,可促宫颈成熟,缩

短产程和提高引产成功率,对产妇和新生儿无不良影响,可用于妊娠晚期,计划分娩及中期妊娠引产。比雌三醇、雌二醇对宫颈成熟度影响好,对产后出血、子宫复旧、乳汁分泌和新生儿1minApgar评分正常。个别患者出现恶心眩晕,行走乏力等一过性反应。用法为:100mg溶于5%葡萄糖溶液或注射用